La trasmissione di comportamenti disfunzionali dai genitori ai figli e un efficace modello di intervento psicoterapeutico

ISBN 88-7078-694-3

J. Manzano F. Palacio Espasa N. Zilkha Scenari della genitorialità

raellocortina.it

J. Manzano F. Palacio Espasa
N. Zilkha

Scenari della genitorialità

La consultazione genitori - bambino

Una volta effettuata questa trasformazione difensiva, la riparazione dell'oggetto genitoriale danneggiato viene compiuta tramite l'identificazione complementare del genitore con un'immagine genitoriale piena di sollecitudine. Lo stesso processo è utilizzato al momento della proiezione sul bambino di aspetti infantili dei genitori vissuti come abbandonati o carenziati. L'identificazione complementare con una rappresentazione genitoriale idealizzata trasforma l'immagine del bambino abbandonato in un'immagine di "bambino idealmente coccolato".

Questi processi difensivi ci confermano l'aspetto narcisistico delle proiezioni genitoriali, che sono portatrici di aspetti della vita pulsionale dei genitori stessi, come abbiamo precedentemente sottolineato.

CONSEGUENZE SUI BAMBINI

Nelle situazioni che abbiamo descritto, i bambini presentano, per la maggior parte, manifestazioni sintomatiche della serie depressiva, risultato della tendenza a identificarsi con l'imago genitoriale danneggiata proiettata su di loro.

Tuttavia, alcuni tra essi, e soprattutto i più piccoli, hanno la tendenza a ricorrere a difese maniacali contro questi stessi vissuti depressivi.

VII

L'OMBRA DELL'OGGETTO DEI GENITORI

PROIEZIONE SUL BAMBINO DI UN OGGETTO GENITORIALE IDEALIZZATO

Ci proponiamo di affrontare, ora, le situazioni in cui lo scenario narcisistico consiste nel proiettare sul bambino l'immagine di un oggetto genitoriale idealizzato, del quale egli diventa così il depositario.

Questo genere di figura costituisce l'analogo della proiezione, da parte del genitore, del bambino ideale che era stato, o che aveva creduto di essere, diretto portatore del narcisismo infantile proiettato.

Nel quadro della proiezione, da parte del genitore, di rappresentazioni genitoriali idealizzate, abbiamo incontrato un più ampio repertorio di tematiche proiettive, in relazione alla varietà degli aspetti genitoriali particolarmente idealizzati.

Un certo numero di caratteristiche ben si presta all'idealizzazione.

Per esempio: 1) le capacità genitoriali di rispondere ai bisogni anaclitici di presenza, di soddisfacimento e di sicurezza (che riportano alla nozione di pulsioni di autoconservazione, come vedremo più avanti); 2) gli aspetti genitoriali investiti in modo superegoico e dai quali derivano esigenze cui il genitore accetta di sottomettersi; 3) gli aspetti dell'oggetto genitoriale investito in maniera incestuosa nel quadro della conflittualità edipica del genitore.

Le situazioni cliniche che seguono rimandano a questa categorizzazione un po' sommaria e l'arricchiscono.

IL SORRISO DI SOLLIEVO DI RÉGINE

Proiezione di un oggetto genitoriale idealizzato considerato "buono", perché protegge da un vissuto di perdita.

Madre e figlia sono presenti alla prima seduta. La madre racconta che Régine, di nove anni, soffre di difficoltà di separazione "da sempre". Non sopporta di passare la notte se non a casa. L'anno scorso aveva addirittura rinunciato a una vacanza con la madrina, a cui è molto affezionata. Oggi, la bambina dice chiaramente che le piacerebbe che fosse altrimenti, e questo induce la madre a chiedere una consultazione. Da qualche giorno, Régine è partita in gita scolastica, ma ha passato la notte in camera dell'insegnante perché era troppo agitata. La bambina spiega che pensava costantemente alla mamma e alla famiglia, sperando che andasse tutto bene per loro. La madre aggiunge che Régine si mostra angosciata quando i genitori o la sorella minore perdono o smarriscono un oggetto qualunque.

Spontaneamente, la madre collega le difficoltà della figlia alle proprie paure – giustificate dal punto di vista medico – di perdere la bambina durante la gravidanza. Anche in seguito, la paura di perderla è continuata. Anche lei, da bambina, viveva male le separazioni. Ha un ricordo doloroso di essere stata mandata in colonia all'età attuale di sua figlia e vuole ardentemente proteggere Régine da qualsiasi separazione. Fa notare che non ha le stesse paure per la figlia minore che, oltretutto, ama rimanere presso le sue amichette.

Con un po' di incoraggiamento da parte della terapeuta, la madre continua la propria storia. I genitori sono entrambi morti: il padre da una dozzina d'anni e la madre quando era adolescente. A questo ricordo, cerca palesemente di non piangere. Régine, una bambina intelligente e vivace, è molto attenta ai discorsi della madre e alla sua mimica. Pone alcune domande riguardo alla ragione delle morti. La terapeuta si rivolge allora alla bambina: "Prima, la mamma era molto preoccupata che tu rischiassi di essere triste e adesso sei tu che pensi che non devi lasciare la mamma". La madre è visibilmente stupita. Régine sorride sollevata. Chiede di rivedere la terapeuta e, con la madre, organizza, con il viso sempre sorridente, un breve soggiorno da una cugina che ama molto.

Analisi del caso

Proiezione sul bambino. La madre proietta sulla figlia l'immagine della "buona" madre che non la espone mai a sentimenti di abbandono.

Contro-identificazione del genitore alla proiezione. La madre si controidentifica con la bambina che avrebbe voluto essere, e che sarebbe stata protetta dal vissuto di perdita.

Scopo della proiezione. Questa proiezione le permette di negare il lutto, ancora doloroso, per la propria madre.

Reazione del bambino alla proiezione. La bambina si identifica con l'oggetto proiettato.

Comprensione dei sintomi. Le difficoltà di separazione notturna derivano da questa identificazione. Per di più, per spostamento dell'oggetto materno, la bambina si preoccupa per gli oggetti persi, per evitare che la madre ne sia addolorata. Con la crescita, sintomi di questo tipo non corrispondono più ai desideri e alle aspettative dei genitori o della bambina, e questo induce i genitori a chiedere una consultazione.

Pretransfert del genitore. La madre proietta sulla terapeuta un'imago materna capace di rispondere ai suoi bisogni emotivi infantili. Il pretransfert è dunque positivo.

Pretransfert del bambino. La bambina investe positivamente la terapeuta. Spera di essere scaricata dal compito di supportare i bisogni anaclitici della madre e potere così sviluppare la propria autonomia.

Contro-reazioni della terapeuta. Le contro-reazioni della terapeuta sono comunque positive, malgrado una certa reticenza di fronte alla domanda implicita della madre di assumere il ruolo proiettato nel pretransfert.

Interventi e interpretazioni. L'interpretazione unica indirizzata alla bambina – ma destinata anche alla madre – prende in considerazione sia la negazione del lutto della madre, grazie alla proiezione selettiva, da parte di quest'ultima, di una madre ideale, sia la responsabilità della figlia nell'accettare questa proiezione.

In questa prima consultazione, l'interpretazione adeguata dei fantasmi di abbandono che la madre proietta sulla figlia e che la figlia a sua volta teme per la madre, sorprende ambedue. La madre si rende conto della pressione che esercita sulla bambina e che è legata al lutto per i propri genitori, e in particolare per la madre. Régine, sollevata del peso

della proiezione, reagisce "sul campo" ed elabora un progetto in cui la separazione dalla madre non costituisce più un ostacolo.

ALBERT SI DIVERTE A LANCIARE LA "BAMBOLA-PAPÀ"

Proiezione di un oggetto genitoriale edipico idealizzato di natura incestuosa.

Alla prima consultazione, i genitori di Albert (due anni e tre mesi) si lamentano delle difficoltà di sonno del figlio. Fin dalla nascita della sorellina, da qualche mese, si sveglia, secondo i genitori, otto o dieci volte per notte e ha delle crisi di collera impressionanti se essi non restano con lui. Ciò suscita dei conflitti tra gli stessi genitori; la madre, più permissiva del marito, rimprovera a quest'ultimo di arrabbiarsi con Albert. Molto rapidamente, apprendiamo che la madre è la maggiore dei suoi fratelli e ha molto sofferto per la "rigidità di principi di suo padre", che si sarebbe invece dimostrato "più morbido" con i fratelli minori. Il terapeuta sottolinea la sua paura, fin dalla nascita del secondo figlio, di dimostrarsi ingiusta verso la maggiore, come lo era suo padre.

Alla seconda consultazione, il padre è assente. La madre dice di essere stata sorpresa della "passione" che ha provato per Albert fin dalla nascita. Nota che, con la figlia, la relazione è differente e le sembra "meno nevrotica". Durante questa seduta, Albert gioca con una bambola che chiama papà e che lancia "lontano", secondo le sue stesse parole. In seguito si mostra esigente verso la madre e vuole accaparrarsi tutta la sua attenzione. Il terapeuta gli dice che vuole gettarlo lontano come ha gettato lontano la bambola-papà. La madre spontaneamente conferma che di notte è tirannico e accetta accanto soltanto lei.

Nella seduta successiva, il desiderio del bambino di mantenere l'esclusiva della relazione con la madre e di separarla dal terapeuta è ancora più intenso. Addirittura, prende la mano della madre per farla uscire dallo studio. A dispetto degli sforzi del bambino, il terapeuta riesce ad approfondire il passato della madre. Ella ricorda una madre poco affettuosa e partecipe. Quando era adolescente, questa immagine ha rafforzato i suoi dubbi riguardo ai propri desideri di maternità; ha paura di diventare come lei. In più, il padre, con il quale aveva avuto una relazione molto affettuosa da bambina, si è dimostrato "rigido" in quel periodo. Il terapeuta le parla allora della sua paura di distruggere la relazione di intimità che ha con Albert, mettendo dei limiti alla sua tirannia.

Alla quarta consultazione, Albert dorme meglio, ma si sveglia ancora spesso una volta per notte. Adesso accetta che il padre rimanga vicino a lui e frequentemente si riaddormentano insieme. Nello studio del terapeuta, il bambino è più calmo e non ha più atti di autoritarismo forsennato. Nel corso delle proprie associazioni, la madre fa un lapsus e chiama Albert con il nome di suo fratello minore – il preferito della madre – di cui è stata molto gelosa, ma nei confronti del quale si è sentita anche colpevole quando, da adolescente, ha avuto gravi difficoltà. Il terapeuta esplicita la sua tendenza a riconoscere in Albert, quando è calmo, il fratello minore che ha avuto tanti problemi.

Alla seduta successiva, la madre interpella il padre, anch'egli presente, attribuendogli la responsabilità di alcune difficoltà di sonno che persistono in Albert. Afferma che il marito si aspetta di essere chiamato la notte dai bambini per potersi dimostrare comprensivo con loro perché, come lei, ha sofferto per un padre autoritario. Il marito accondiscende e riconosce che la moglie sembra adesso più a proprio agio nel porre dei limiti al figlio, mentre egli ha paura di diventare inflessibile come suo padre. Il terapeuta, testimone di questi tentativi di comprensione, non ritiene utile aggiungervi alcuna interpretazione.

Il terapeuta vede la famiglia un'ultima volta. La madre si scusa di averlo utilizzato come riferimento autoritario verso il figlio. In effetti, quando questi l'ha svegliata con il pretesto di una grande sete, gli ha annunciato che non gli darà più acqua poiché "il dottore ha detto che sei un ragazzo grande". Si rende conto di essersi appoggiata all'autorità del terapeuta per non sentirsi egoista, come ha vissuto che fossero i suoi genitori.

Il bambino è stato rivisto all'età di cinque anni per una catamnesi. La sua crescita è soddisfacente. Organizza la propria conflittualità intrapsichica su un piano nevrotico. Alcuni tratti di tipo fobico risaltano in manifestazioni simboliche dell'angoscia di castrazione, ma queste non invadono la relazione col terapeuta.